Ictère néonatal et traitement par photothérapie au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo

Nom du présentateur : Caroline Yonaba/ Okengo

Caroline Yonaba, Oumarou Sawadogo, Safièta Kabore, Sirinatou Ilboudo, Angele Zongo, Fla Koueta

CHU Yalgado Ouedraogo

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Environ 60 % des nouveau-nés à terme et 85 % des nouveau-nés prématurés développeront un ictère la première semaine de vie
- Majorité des cas = ictère à bilirubinémie non conjuguée avec un risque d'évolution vers des complications neurologiques graves (=ictère nucléaire)
- Ictère et ses complications chez le NN = urgence diagnostique et thérapeutique

Introduction

- Photothérapie = moyen thérapeutique efficace pour prévenir les complications
- Au Burkina Faso, elle est de plus en plus disponible; cependant les données sur son utilisation et son efficacité sont rares
- But : contribuer à l'amelioration de la PEC des NNE ictériques

Objectif

- OG: faire un état des lieux du traitement par la photothérapie de l'ictère néonatal au CHU-YO
- OS:
  - ✓ Déterminer fréquence des NN traités par photothérapie
  - ✓ Décrire caractéristiques sociodémographiques des NN inclus
  - ✓ Décrire la contribution de la photothérapie à la prise en charge de l'ictère néonatal
  - ✓ Identifier les modalités évolutives des nouveau-nés ictériques sous photothérapie

Matériel et méthode(s)

- Etude observationnelle descriptive à collecte prospective réalisée du 20/10/2023 au 30/03/2024 dans le service de pédiatrie du CHU-YO.
- Ont été inclus tous les nouveau -nés hospitalisés, présentant un ictère et qui ont bénéficié d'un traitement par la photothérapie.
- Données socio-démographiques, cliniques, paracliques, thérapeutiques et évolutives au cours de l'hospitalisation ont été enregistrées

Résultats

Caractéristiques épidémiologiques

Nombre total de nouveau-nés reçus durant la période d'étude (N=2184)

↓

Nouveau-nés ictériques (N=168)

7,7%

↓

Nouveau-nés mis sous photothérapie (N=115) 68,5%)

→ Garçons : 64%
Age < 3 jours: 68%

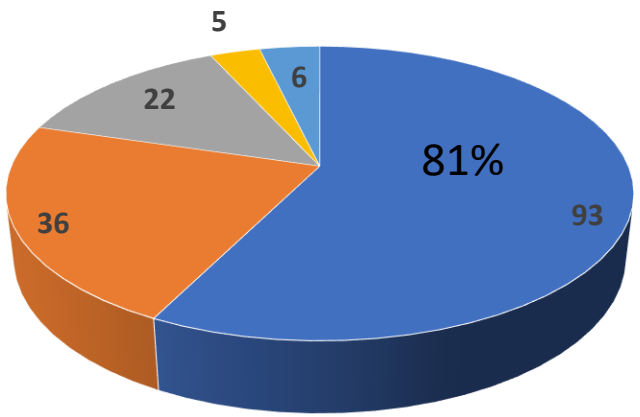
Résultats

Principales caractéristiques cliniques (N=115)

Signes	n	%
Ictère précoce	61	**53**
Apgar < 7	14	12
PN < 2500g	43	**37**
Prématuré	13	11
Fièvre	78	**68**
Pâleur	7	6

Résultats

Principales étiologies évoquées chez les NNE ictériques



- Infection néonatale
- Incompatibilité fœto-maternelle dans le système ABO
- Indéterminée
- Incompatibilité dans le système Rhésus
- autres (prematurité,resorption hématome)

Modalités photothérapie

Variable	n	%
Délai de mise sous photothérapie (n=115)		
≤24 h	91	**79**
]24 H- 48h]	16	14
> 48 H	8	7
Nombre de séances/jr (n=115)		
2	36	31,3
3	79	**68,7**
Nombre d'heures par séance(n=115)		
3H	14	12,2
4H	101	**87,8**
Saut de séances par jour(n=23)	23	**20**
1 fois	8	34,8
2 fois	13	**56,5**
3 fois	2	8,7

Photothérapie conventionnelle

Résultats

Persistance de l'ictère après le début de la photothérapie

Période (jours)	n	%
≤3	97	**84**
4-5	28	29
6-7	6	21

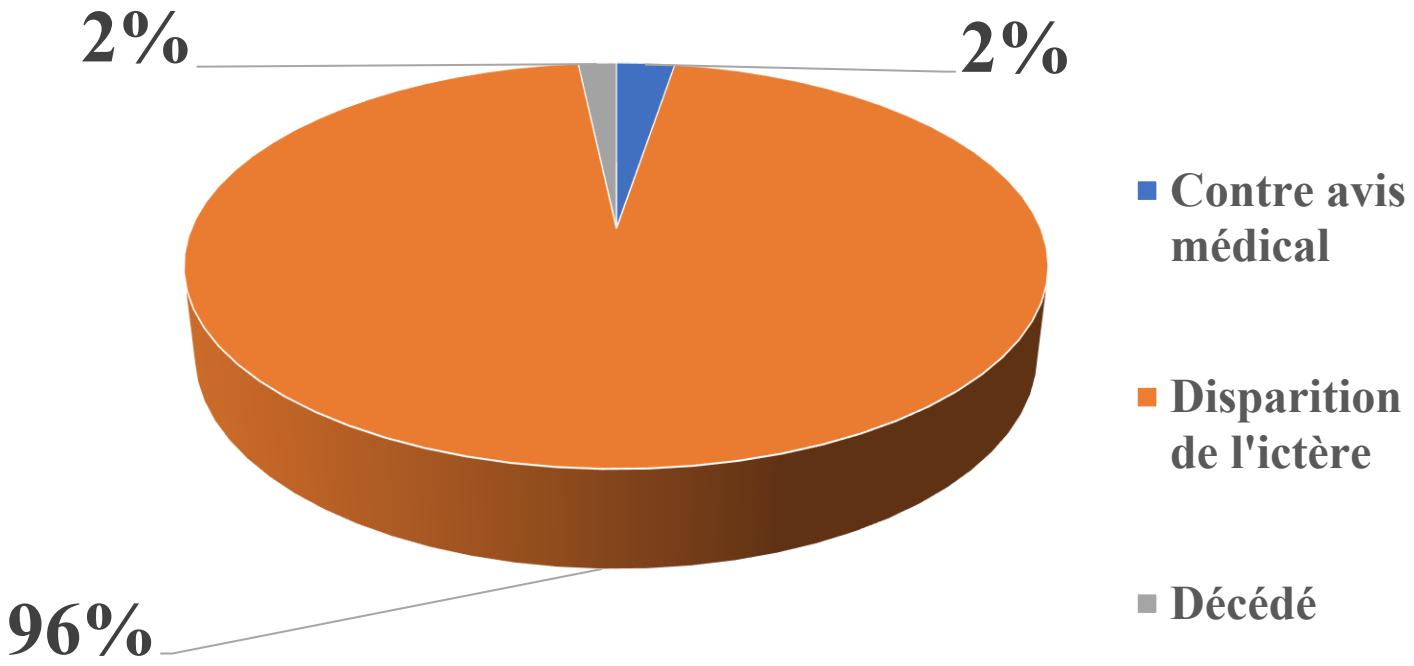
Durée de la photothérapie à la sortie (jours)

Durée (jours)	n	%
[2-3]	18	16
[4-5]	69	**60**
≥ 6	28	24

Durée totale moyenne de la photothérapie était de 5 jours

Résultats

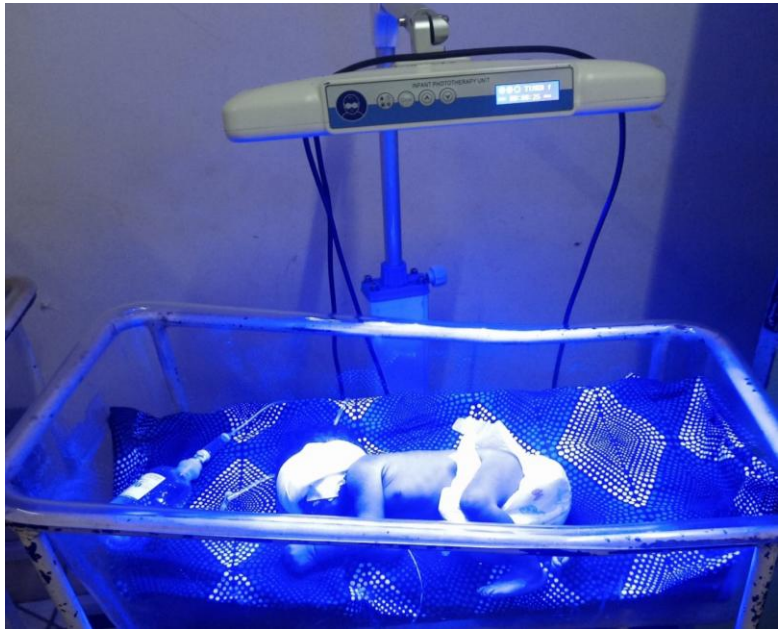
Mode de sortie des nouveau-nés ictériques traités par la photothérapie



Durée moyenne d'hospitalisation: 9 jours +/- 3 jours

Conclusion

- Les esoins en photothérapie sont énormes dans le service
- Des appareils plus performants et modernes doivent être disponibles
- La maintenance préventive des appareils est nécessaire pour réduire les arrêts fréquents de traitement
- La prévention de l'ictère est la clé du traitement , lutte contre les infections materno - fœtales etc+++



Séance de photothérapie dans l'unité de clinique pédiatrique du CHU YO

Merci pour votre attention